

갑상선암 진단 첫 30일

관찰 · 수술 범위 · 방사성요오드 결정

처음 진단받은 환자와 보호자를 위한 핵심 정리 · 질문 · 행동 가이드

ApuDa 「암 진단 첫 30일」 시리즈 05

완전판 · 2026년 10월 개정 2판

갑상선암은 ‘얼마나 빨리’보다 ‘얼마나 적절하게’ 치료하느냐가 중요합니다.

이 책을 펴기 전에

- 이 책은 **일반적인 환자교육 자료**입니다. 나의 병기, 치료 순서, 약 선택, 예후는 담당 의료진과 함께 결정합니다.
- 의학정보 확인일: **2026.10.04** · 참고 지침: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology — Thyroid Carcinoma, Version 2.2026 외 국내 자료(본문 끝 「근거와 한계」 참고)
- 약의 국내 허가·건강보험 급여 기준과 제도(산정특례·지원사업)는 자주 바뀝니다. 실제 적용 전 병원 원무과·국민건강보험공단(1577-1000)에서 다시 확인하세요.
- 이 책은 NCCN이 검토하거나 승인한 자료가 아니며, ApuDa가 독자적으로 쓴 환자교육 저작물입니다.

이 책의 사용법

이 책은 처음부터 끝까지 읽는 책이 아닙니다. **지금 내 상황에 필요한 장만 펴서 쓰는 책**입니다.

지금 내 상황	먼저 펼 곳
방금 진단을 들었고 머리가 하얗다	1장 「먼저 구분하세요」 → 「진단 뒤 72시간」
몸에 이상 신호가 있다	「기다리지 않는 신호」 (응급 상자)
다음 주에 진료가 잡혀 있다	해당 치료 장 + 워크북 「진료 기록지」
검사 결과지를 받았다	PART 1의 병리·검사·병기 장
돈·보험·회사가 걱정이다	PART 5 「돈 · 서류 · 제도」
마음이 무너질 것 같다	PART 4 「마음 돌보기」
가족으로서 무엇을 해야 할지 모르겠다	PART 4 「보호자에게」

각 장의 구성은 같습니다.

- **30초 요약** — 바쁠 때는 이 상자만 읽어도 됩니다.
- **본문** — 왜 그런지, 무엇을 확인하는지.
- **오늘 물어볼 질문** — 진료실에 가져갈 질문은 장마다 3개 이내로 골랐습니다.
- **기록칸** — 들은 내용을 그 자리에서 적습니다. 보호자가 적어도 좋습니다.
- **🆘 응급 상자** — 기다리지 말고 연락해야 하는 신호입니다.

이 책의 표시:  확정된 정보 ·  검사·결정 대기 ·  아직 모름/확인 필요.
색이 아니라 기호로 구분했으니 흑백으로 인쇄해도 그대로 쓸 수 있습니다.

PART 1. 진단 첫 주 — 정확히 알기

1장. 먼저 구분하세요: 조직형과 위험도

30초 요약

- 갑상선암의 대부분은 **분화암(유두암·여포암)**으로 경과가 좋은 편입니다. 그러나 **저분화암·역형성암·수질암**은 치료가 다릅니다.
- 치료는 "빨리 전부 떼기"만이 길이 아니라 **위험도에 맞춘 선택**입니다: 적극적 관찰 / 엽절제 / 전절제 / 방사성요오드.
- 예후가 좋은 편이라는 것과 **지금 힘든 것은 함께 존재할 수 있습니다.** "착한 암"이라는 말에 마음이 다쳤다면 그 감정도 정당합니다.

조직형	특징	치료의 축
유두암	가장 흔함, 대개 천천히 자람	관찰 또는 수술 ± 방사성요오드
여포암	혈관을 통해 퍼질 수 있음	수술 ± 방사성요오드
호산성(옥시필) 세포암	이전 이름 '휘틀세포암'	수술 ± 방사성요오드(반응이 낮을 수 있음)
저분화암·고등급 분화암	분화암과 역형성암 사이	더 적극적인 수술·추적·분자검사
수질암	칼시토닌을 만드는 세포, 유전 가능성	수술 전 부신·부갑상선 확인, 유전검사
역형성암	드물고 빠르게 자람	신속한 다학제 진료 , 분자검사 (BRAF 등)
NIFTP	암이 아닌 저위험 종양으로 재분류	대개 엽절제로 충분

결과지 용어 연결

- **K-TIRADS 3/4/5:** 초음파로 본 악성 가능성 등급 — 확진이 아닙니다.
- **Bethesda 1~6단계:** 세침흡인 세포검사 결과(1 진단불가 / 2 양성 / 3 비정형 / 4 여포종양 / 5 악성 의심 / 6 악성).

오늘 물어볼 질문

1. 제 결과는 Bethesda 몇 단계이고, 조직형은 무엇인가요?
2. 적극적 관찰이 가능한가요, 수술이 필요한가요?
3. 수술한다면 엽절제와 전절제 중 무엇을 권하시나요?

2장. 기다리지 않는 신호

⚠ 응급 상자 수술 전·진행암

- 목 덩이가 빠르게 커짐, 숨이 차거나 쌉쌉거림, 삼키기 어려움, 피 섞인 가래, 갑자기 쉰 목소리 **수술 후**
- 목이 갑자기 붓고 숨이 참(출혈·혈종) → 즉시 응급실(119)
- 입 주위·손발 저림, 근육 경련·쥐(저칼슘) → 처방받은 칼슘을 먹고 바로 연락. 심하면 응급실
- 38°C 이상 발열과 상처 발적·고름
- 스스로를 해치고 싶은 생각 → ☎ 109, 119

본문 목록:

1. 빠르게 커지는 목 덩이·호흡곤란은 공격적인 갑상선암이나 출혈일 수 있습니다.
2. 수술 후 목 부종과 숨참은 혈종이 기도를 누르는 응급입니다.
3. 저림·경련은 부갑상선 기능 저하에 의한 저칼슘 신호입니다.
4. 상처 감염은 빨리 치료할수록 좋습니다.

3장. 진단 뒤 72시간

30초 요약: 오늘은 ① 세포검사 결과지 받기 ② 갑상선 전문 진료(내분비외과·내분비내과) 예약 ③ 임신 계획 메모. **대부분 서둘러 오늘 결정할 필요는 없습니다.**

오늘 할 일 (3개)

- ☐ 세포검사 결과지(Bethesda 단계)와 초음파 판독지(K-TIRADS) 사본
- ☐ 갑상선 전문 진료 예약
- ☐ 임신·수유 계획이 있다면 메모 — 관찰·수술·방사성요오드 모두 계획 단계부터 알려야 합니다

이번 주 할 일

- ☐ 목 림프절 초음파, 필요 시 CT(조영 CT는 방사성요오드 일정과 연결되므로 **순서를 의료진이 정함**)
- ☐ 혈액검사(갑상선 기능, 수질암 의심 시 칼시토닌·CEA)
- ☐ 산정특례 신청 여부 원무과 확인(확진 후 30일 이내; 적극적 관찰만 하는 경우 적용 여부 확인)
- ☐ 보험 약관에서 갑상선암 분류(유사암·소액암) 확인

오늘 물어볼 질문

1. 제 결절의 크기·위치·림프절 상태는 어떤가요?
2. 추가 검사(분자검사·CT)가 필요한가요?
3. 결정까지 시간은 얼마나 있나요?

4장. 병기와 위험도

30초 요약: 분화암은 **55세 기준**으로 병기 체계가 달라, 55세 미만은 원격전이가 없으면 림프절 전이가 있어도 1기입니다. 치료 결정에는 병기보다 **재발 위험도(저·중간·고위험)**가 더 많이 쓰이며, 치료 후 반응에 따라 **다시** 평가됩니다.

재발 위험도	예시	흔한 접근
저위험	작은 종양, 갑상선 안에 국한, 공격적 소견 없음	관찰 또는 엽절제, 방사성요오드 대개 생략
중간위험	미세한 갑상선 밖 침범, 림프절 전이 일부 등	전절제 고려, 방사성요오드 선택적
고위험	육안적 침범, 원격전이, 불완전 절제	전절제 + 방사성요오드

- 치료 후 반응(혈액 티로글로불린·영상)이 좋으면 추적 간격과 **TSH 목표**가 완화될 수 있습니다.

Bethesda 단계별 다음 단계(일반적)

단계	흔한 다음 단계
1 진단불가	재검
2 양성	추적 초음파
3 비정형 / 4 여포종양	재검, 분자검사, 진단적 엽절제 상의
5 악성 의심 / 6 악성	수술 또는(조건이 맞으면) 적극적 관찰

가상 결과지 읽기

Thyroid, right lobe, FNA: Bethesda VI, papillary thyroid carcinoma US: 0.8 cm, K-TIRADS 5, no extrathyroidal extension, no suspicious LN → 0.8cm 유두암, 갑상선 밖 침범·림프절 의심 없음. **적극적 관찰과 엽절제를 모두 상의할 수 있는 상황**일 수 있습니다(위치·나이·선호에 따라).

PART 2. 치료 결정 — 2~3주차

5장. 적극적 관찰

30초 요약: 1cm 이하 저위험 유두암 일부는 **바로 수술하지 않고 정기 초음파로 지켜보는 것**이 선택지입니다. 크기만이 아니라 **위치(기관·성대신경 가까이 있는지)·세포 소견·추적 가능성**을 함께 봅니다.

- 크기가 늘거나 림프절 전이가 나타나면 그때 수술로 바꿉니다. 국내 자료로는 5년 동안 지켜봤을 때 진행하는 경우가 10명 중 1명 정도이고, 나이가 많고 종양이 작을수록 더 적습니다. 진행해서 수술하더라도 대부분 완치를 기대할 수 있습니다. 적극적 관찰은 성인에게만 고려합니다.
- 관찰도 **치료 전략**입니다. "아무것도 안 하는 것"이 아닙니다.
- 임신 계획이 있다면 관찰 중 임신에 대해 미리 상의합니다.

관찰 기록장

날짜	크기(cm)	림프절	결정	메모

6장. 수술: 엽절제 vs 전절제

30초 요약

- **엽절제**: 한쪽만 제거. 호르몬제를 먹지 않아도 되는 경우가 많고 부갑상선·성대신경 위험이 낮습니다.
- **전절제**: 양쪽 모두 제거. 평생 갑상선호르몬제를 먹습니다. 종양이 크거나 양쪽에 있거나 갑상선 밖 침범·전이가 있을 때, 또는 방사성요오드가 필요할 때 시행합니다.
- 엽절제 후 최종 병리에 따라 **남은 쪽 추가 수술(완결 갑상선절제술)**을 권유받을 수 있습니다. 처음 수술이 잘못된 것이 아니라 **정보가 추가된 결과**입니다.

비교	엽절제	전절제
호르몬제	필요 없을 수도	평생 필요
부갑상선 저하 위험	매우 낮음	일시적 저하 흔함(대개 1~2개월 안 회복), 영구는 약 1~2%
방사성요오드	불가	가능
추적	초음파	초음파 + 티로글로불린

- 수술 방법(목 절개, 로봇, 내시경, 입안 접근 등)은 흉터·비용·적응이 다릅니다. 우열보다 내 종양에 맞는지를 물어보세요.
- 국내에서는 갑상선 로봇수술이 아직 건강보험 급여가 되지 않아 비용 부담이 크고, 진행된 암에는 대개 권하지 않습니다. 합병증·재발 같은 결과는 목 절개 수술과 비슷하다고 알려져 있습니다. 예상 비용과 실손보험 적용 여부를 원무과에 미리 확인하세요(2026.10 기준, 확인 필요).

수술 후 2주 회복 일지

날	목 소 리	저림 · 경련	상 처	삼 킴	메 모
1					
3					
7					
14					
- 목소리 변화는 대부분 몇 주~몇 달 안에 좋아집니다. 몇 주가 지나도 나아지지 않거나 물 마실 때 사레가 자주 들리면 성대 검사(후두내시경)를 일찍 상의합니다.					

7장. 방사성요오드 치료

30초 요약: 방사성요오드는 **선택적**입니다. 저위험군은 대개 생략하고, 중간위험은 선택적으로, 고위험군에 주로 씁니다. 하게 된다면 **저요오드 식사**와 **TSH 올리기**가 준비의 핵심입니다.

- 저요오드 식사:** 치료가 정해지기 전에 미리 극단적으로 바꿀 필요는 없습니다. **일정이 정해지면** 병원 식단표대로 보통 1~2주 동안 **김·미역·다시마 등 해조류, 천일염·요오드 함유 소금, 해산물** 등을 제한합니다.
- TSH 올리는 방법:** 갑상선호르몬제를 보통 치료 약 4주 전부터 끊는 방법(그동안 몸이 피곤하고 몸이 붓는 등 기능저하 증상이 생길 수 있어 운전·업무 일정 조정 필요) 또는 **재조합 TSH 주사**(일상 유지, 비용·급여 확인).
- 방사성요오드 예정이라면 다른 병원에서 **조영제 CT**를 찍기 전에 핵의학팀에 알려세요(일정이 밀릴 수 있음).

- 국내에서는 법 규정에 따라 투여 용량이 30mCi를 넘으면 며칠 동안 격리 병실에 입원해야 하고, 그보다 적으면 외래에서 먹고 집에 가기도 합니다. 내 용량과 입원 여부, 격리 병실 예약 시기를 미리 물어보세요(확인 필요).
- 치료 후 **임신·수유는 일정 기간 미룹니다**. 국내 안내로는 여성은 치료 뒤 적어도 6개월, 남성은 약 3개월이 지나서 임신을 계획하도록 권합니다. 치료 전에는 임신 여부를 먼저 확인합니다(투여량에 따라 다를 수 있어 담당 핵의학과 확인).

저요오드 식사 실전

피하기	가능한 대안(병원 식단표 우선)
김·미역·다시마, 해산물	고기·달걀흰자·채소
천일염·요오드 소금, 젓갈·김치 (시판)	요오드를 넣지 않은 정제염으로 간한 집 반찬 — 저요오드식은 저염식이 아닙니다. 소금을 너무 줄이면 드물게 혈중 나트륨이 떨어질 수 있습니다
우유·치즈· 달걀노른자 (병원에 따라)	두유(성분 확인)
외식·배달 국물	집밥, 편의점은 성분표 확인

치료 후 가족 수칙(투여량별 병원 지침이 우선)

- 퇴원 뒤 약 1주일엔 따로 자고 포옹·입맞춤 같은 가까운 접촉을 줄이며, 특히 **어린이·임신부와 거리 두기**(기간은 투여량에 따라 병원 안내 우선). 호르몬제를 끊고 치료했다면 집에 갈 때 직접 운전하지 말고 보호자와 함께 가세요.
- 화장실 물 두 번 내리기, 식기·수건 분리
- 반려동물과도 밀접 접촉 줄이기

입원 짐

- 격리 병실에서 쓸 물건(오염 시 폐기될 수 있으니 버려도 되는 것 위주), 물·사탕 (침샘 보호에 레몬사탕을 권하기도 함), 슬리퍼

8장. 갑상선호르몬제와 TSH

30초 요약: 전절제 후에는 **평생 호르몬제**를 먹습니다. **아침 공복**, 같은 시간, 철분·칼슘제와 4시간 간격. TSH 목표는 위험도에 따라 다르며, 과도한 억제는 심장·뼈 부작용이 있어 개인별로 정합니다. 임신 중에도 계속 먹고, 임신 확인 즉시 용량을 상의합니다.

9장. 진행·재발성, 수질암·역형성암

30초 요약

- **방사성요오드 불응성** 분화암·저분화암: 진행 속도와 증상에 따라 관찰, 수술·방사선, **다중표적 표적치료제**(대표 예: 렌바티닙) 또는 **분자검사 (BRAF·RET·NTRK 등)에 따른 표적치료** 범주(국내 허가·급여 확인 필요).
- **수질암:** 수술 전에 **부신(갈색세포종)·칼슘(부갑상선)** 검사를 했는지 확인하고, RET 유전검사와 가족 상담을 합니다.
- **역형성암:** 빠른 진행이 흔해 **며칠 안에 다학제 진료**와 분자검사(BRAF V600E 등)를 진행합니다.

진행·전이로 진단받았다면

30초 요약

- 전이가 있어도 치료 선택지는 있습니다. 치료 목표가 **암을 조절하며 오래, 덜 아프게 사는 것**으로 바뀌는 경우가 많습니다.
- **완화(지지)의료는 마지막 단계의 돌봄이 아닙니다.** 진단 시점부터 항암치료와 함께 통증·피로·숨참·불안을 줄이는 치료입니다.
- 첫 진료에서 "제 치료 목표는 무엇인가요?"를 꼭 물어보세요.

치료 목표를 묻는 질문

1. 이 치료의 목표는 무엇인가요? (암 크기 줄이기 / 진행 늦추기 / 증상 줄이기)
2. 치료 효과는 언제, 어떤 검사로 확인하나요?
3. 이 치료를 받지 않거나 쉬면 어떤 일이 예상되나요?

완화의료 이용하기

- 대부분의 암 병원에 **완화의료팀(자문형)**이 있습니다. 통증, 숨참, 메스꺼움, 불면, 불안 조절을 담당 교수에게 요청하면 연결됩니다.
- 호스피스·완화의료는 입원형·가정형·자문형으로 나뉘며, 지정 기관과 이용 조건은 국립암센터 중앙호스피스센터 누리집이나 병원 사회사업팀에서 확인합니다.
- 완화医료를 받는다고 해서 항암치료를 포기하는 것이 아닙니다.

미리 생각해 둘 것(원할 때만)

- **사전연명의료의향서**: 19세 이상이면 건강할 때도 작성할 수 있습니다. 보건소·지정 등록기관에서 작성하며, 언제든지 변경·철회할 수 있습니다 (국립연명의료관리기관).

- 치료를 잠시 쉬거나 멈추는 선택도 존중되는 결정입니다. 결정은 한 번에 하지 않아도 됩니다.
- 내가 직접 말하기 어려워질 때 나 대신 의견을 전할 사람을 정해 가족에게 알려 드립니다.

2차 소견과 병원 선택

30초 요약

- 2차 소견은 담당 의사를 의심하는 일이 아니라 **큰 결정을 확인하는 일**입니다. 대부분의 의사는 자연스럽게 받아들입니다.
- 2차 소견 때문에 치료를 몇 주씩 미루지 않도록 **일정을 먼저 정하고** 움직입니다.
- 가장 중요한 준비물은 병리 슬라이드·블록과 영상 CD입니다.

2차 소견이 특히 도움이 되는 경우

- 병리 결과가 드문 조직형이거나, 병원마다 해석이 갈릴 수 있다고 들었을 때
- 수술과 비수술 치료 중 선택지가 둘 이상일 때
- 기능 보존 수술이나 드문 치료처럼 경험 많은 센터가 중요한 치료일 때
- 설명을 들었는데도 결정이 서지 않을 때

병원을 고를 때 물어볼 것

1. 이 병원에서 갑상선암 환자를 **다학제(여러 과가 함께 보는) 진료**로 상의하나요?
2. 제게 필요한 치료(수술·방사선·항암·임상시험 등)를 **한 병원**에서 받을 수 있나요?
아니면 연계 병원이 정해져 있나요?
3. 치료 중 밤이나 휴일에 문제가 생기면 **어디로 연락**하나요?
4. 첫 치료까지 대략 몇 주가 걸리나요?

집과의 거리도 중요한 기준입니다. 매일 가야 하는 방사선치료나 잦은 외래가 예정되어 있다면, 통원 부담과 응급 시 이동 시간을 함께 따져 보세요.

2차 소견 준비 체크리스트

- ☐ 진료의뢰서(상급종합병원은 필수)
- ☐ 병리보고서 + 슬라이드/블록 대여
- ☐ 영상 CD + 판독지
- ☐ 혈액검사 결과, 복용 약 목록
- ☐ 내가 가장 궁금한 질문 3개(워크북 「질문지」)

최신 치료와 임상시험

- 임상시험은 "마지막에 기대는 실험"만이 아닙니다. 진단 초기부터 **표준치료와 함께 고려할 수 있는 선택지**입니다.
- 임상시험에 참여해도 언제든 그만둘 수 있고, 위약(가짜약)만 단독으로 쓰는 암 임상시험은 드뭅니다. 위약이 포함되면 사전에 설명을 듣습니다.
- 연구 약값은 보통 연구 쪽이 부담하지만, 교통비·추가 방문 등 부대 비용은 확인이 필요합니다.

찾는 곳

- 담당 교수에게 "제가 참여할 수 있는 임상시험이 있나요?"라고 직접 묻기 — 가장 빠릅니다.
- 한국임상시험포털(KoNECT), 식품의약품안전처 의약품안전나라 임상시험 정보, ClinicalTrials.gov(영문)

물어볼 질문

1. 이 연구는 무엇을 비교하나요? 표준치료를 받지 못하게 되나요?
2. 방문 횟수와 검사가 얼마나 늘어나나요?

3. 중간에 그만두면 어떤 치료를 받게 되나요?

PART 3. 30일 실행 로드맵

Day 0-3 · 확인하기

- ☐ 세포검사·초음파 결과지 ☐ 갑상선 전문 진료 ☐ 임신 계획 메모 ☐ 연락처 저장

Day 4-7 · 검사받기

- ☐ 림프절 초음파 ☐ 혈액검사 ☐ (필요 시) CT 순서 확인 ☐ 산정특례·보험 약관 확인

Day 8-14 · 결정하기

- ☐ 관찰 / 엽절제 / 전절제 결정 ☐ 수술 방법 상의 ☐ 필요 시 2차 소견

Day 15-21 · 준비하기

- ☐ 수술 전 검사 ☐ 목소리·칼슘 교육 ☐ 직장 일정(회복 1~2주 예상)

Day 22-30 · 시작하기

- ☐ 수술 일정 확정 또는 관찰 시작(대부분 30일 안에 서두를 필요는 없음) ☐ (수술했다면) 회복 일지 ☐ 최종 병리가 나오면 방사성요오드 여부 상의
-

PART 4. 치료 중·후의 몸과 마음

"착한 암"이라는 말과 과잉진단 논쟁

30초 요약: 과잉진단 논쟁은 **인구 집단의 검진 정책**에 관한 것입니다. 이미 진단된 내 결절의 치료 방침은 **내 결과로** 정합니다. 주변의 "별거 아니래"라는 말에 상처받았다면, 그 마음을 의료진이나 가족에게 말해도 됩니다.

- "예후가 좋은 편인 건 맞아. 그래도 수술과 회복은 나한테 큰 일이야. 그냥 '고생했다'고 말해 주면 좋겠어."
- 검사 전 불안(스캔 불안)은 흔합니다. 결과 날짜를 미리 알고, 검사 당일에 함께할 사람을 정해 두세요.

추적

- 초음파와(전절제 시) 혈액 티로글로불린·항체로 추적합니다. 간격은 위험도와 치료 반응에 따라 조정됩니다.

치료 중 흔한 증상, 집에서 할 일과 연락 기준

아래는 여러 암 치료에서 공통으로 흔한 증상입니다. **치료 병원의 안내가 항상 우선**이며, "연락" 칸에 해당하면 다음 예약까지 기다리지 마세요.

증상	집에서 할 수 있는 것	연락할 때
메스꺼움·구토	처방받은 구토 예방약을 시간 맞춰 (증상이 생긴 뒤가 아니라 미리). 조금씩 자주, 차갑고 냄새가 약한 음식, 생강차·크래커	하루 3회 이상 구토, 물도 못 마심, 24시간 소변이 거의 없음

증상	집에서 할 수 있는 것	연락할 때
피로	짧은 낮잠(30분 이내), 가벼운 걷기, 우선순위 정해 에너지 아끼기, 도움 요청	숨참·어지럼·심한 창백(빈혈 가능), 일상생활이 불가능
입안 혈음	부드러운 칫솔, 무알코올 가글(소금·베이킹소다 물), 자극적·뜨거운 음식 피하기	통증으로 먹거나 마시지 못함, 흰 반점·출혈, 발열 동반
변비	수분, 걷기, 처방 변비약. 진통제(마약성) 복용 중이면 변비약을 미리 함께	3일 이상 변이 없고 복통·구토, 배가 부풀
설사	수분·전해질(이온음료 희석, 미음), 기름진 음식·유제품·카페인 줄이기, 처방 지사제	하루 4~6회 이상, 밤에도 계속, 혈변, 어지럼·소변 감소, 면역치료 중 설사
불면	일정한 기상 시간, 낮잠 제한, 잠자리에서 휴대폰 멀리, 스테로이드는 아침 복용(지시대로)	2주 이상 계속, 불안·우울 동반
탈모	순한 샴푸, 짧은 머리, 모자·두건·가발, 두피 자외선 차단	— (대개 치료 후 다시 자람)
피부 발진· 건조	순한 보습제 하루 2회 이상, 미지근한 물, 자외선 차단	물집·벗겨짐, 넓게 번짐, 점막(입·눈) 침범
손발 저림	찬 것 피하기(일부 약), 따뜻한 양말·장갑, 낙상 주의	단추·젓가락·걸기가 어려워짐 — 다음 투여 전에 꼭 알리기
식욕 저하· 체중 감소	먹을 수 있을 때 먹기, 고단백 간식, 영양 보충 음료	한 달 5% 이상 체중 감소, 평소의 절반 이하로 1주 이상

열이 나면: 항암 중 38℃ 이상(병원 기준에 따라 37.8℃ 이상 1시간 지속 등)은 **해열제를 먹기 전에 먼저 연락**하는 것이 원칙입니다. 열을 내리면 감염 신호를 놓칠 수 있습니다.

마음 돌보기

30초 요약

- 진단 후 불안, 잠 못 들, 멍함, 화, 눈물은 **흔하고 자연스러운 반응**입니다. 약해서가 아닙니다.
- 2주 넘게 일상이 무너지거나, 스스로를 해치고 싶은 생각이 들면 **혼자 견디지 말고** 바로 도움을 요청하세요.
- 자살·정신건강 위기 상담 ☎ **109**(24시간), 응급 ☎ **119**
- 지금 마음의 고통은 0~10 중 ____ 점. 4점 이상이면 다음 진료에서 그대로 말하세요.

내 마음 온도계(고통 선별)

지난 1주일 동안 내 마음의 고통은 몇 점이었나요? (0 = 전혀 없음, 10 = 극심함)

날짜 점수(0~10) 가장 힘든 것(□ 걱정 □ 잠 □ 통증 □ 돈 □ 가족 □ 일 □ 기타)

- **4점 이상**이 계속되면 다음 진료 때 점수를 그대로 말하세요. 대부분의 암 병원에는 정신건강의학과·임상심리·사회사업팀 연결 경로가 있습니다.
- 불면이 1~2주 이상 계속되면 수면 치료를 받을 수 있습니다. 잠은 치료를 견디는 체력입니다.
- 병원 밖 도움: 전국 지역암센터의 **암생존자통합지지센터**(☎ 1577-9740)에서 상담·심리지지·자기관리 프로그램을 운영합니다. 암 정보가 궁금하면

국가암지식정보센터 상담(☎ 1577-8899, 평일 9~18시)을 이용할 수 있습니다.

불안이 몰려올 때 5분 방법

1. **숨:** 4초 들이쉬고, 6초 내쉬기를 5번.
2. **이름 붙이기:** "지금 나는 ○○ 결과가 걱정된다"라고 소리 내거나 적기.
3. **내 몫 나누기:** 지금 내가 할 수 있는 일 1개(전화 1통, 서류 1장)와 의료진 몫을 나눠 적기.
4. **정보 시간 정하기:** 인터넷 검색은 하루 30분, 정해 둔 시간에만. 밤 검색은 불안을 키웁니다.

"내 탓일까?"라는 생각

암은 한 가지 원인으로 생기지 않습니다. 생활습관, 감염, 유전, 나이, 그리고 설명되지 않는 우연이 겹칩니다. **원인 찾기보다 지금부터의 계획**에 에너지를 쓰는 편이 나를 돕습니다. 가족이나 주변 사람이 원인을 따져 묻는다면 "지금은 치료 계획에 집중하고 싶어"라고 말해도 됩니다.

희망과 현실을 함께 들고 가기

통계(생존율)는 많은 사람의 평균이지 나 한 사람의 예언이 아닙니다. 궁금하다면 담당 의사에게 "제 병기와 상태에서 치료 목표가 무엇인가요?"라고 물어보세요. 듣고 싶지 않은 정보는 "지금은 듣지 않겠다"고 말할 권리도 있습니다.

보호자에게

보호자가 첫 30일에 할 수 있는 가장 좋은 일

- **기록 담당:** 진료실에서 답을 적습니다. 환자는 듣는 데 집중할 수 있습니다.
- **일정 담당:** 검사·진료·서류 일정을 한 곳(달력·앱)에 모읍니다.
- **연락 창구:** 친척·지인에게 소식을 전하는 사람을 한 명으로 정하면 환자가 같은 이야기를 반복하지 않아도 됩니다.

- **결정은 환자가:** 의견은 말하되, 치료 결정의 주인은 환자입니다.

피하면 좋은 말과 바꿔 쓸 말

피하면 좋은 말	바꿔 쓸 말
"긍정적으로 생각해야 나아"	"힘든 마음 그대로 말해도 돼"
"왜 검진을 안 받았어"	"지금부터 같이 챙기자"
"○○ 먹으면 낫는데"	"새로 먹고 싶은 게 있으면 의사 선생님께 같이 물어보자"
"너보다 더 힘든 사람도 있어"	"네가 힘든 건 힘든 거야"

아이에게 알릴 때

- 아이의 나이에 맞게, **짧고 사실대로:** "(엄마·아빠·할머니 등 아이가 부르는 호칭)가 몸에 아픈 혹은 생겨서 병원에서 치료를 받을 거야."
- 아이가 자주 하는 걱정 세 가지에 먼저 답합니다: **네 탓이 아니야 / 옳은 병이 아니야 / 누가 너를 돌봐줄지 정해져 있어.**
- 학교 담임에게 알릴지, 누가 알릴지 미리 정합니다.

보호자의 휴가 제도

일하는 보호자는 **가족돌봄휴직**(연간 최대 90일)과 그 안에서 하루 단위로 쓰는 **가족돌봄휴가**(연간 최대 10일)를 회사에 신청할 수 있습니다(남녀고용평등법, 2026.10 기준·고용노동부 확인). 진료 동행이 잦은 첫 30일에 특히 유용합니다.

보호자 자신을 위해

보호자의 소진은 흔합니다. 하루 30분은 나를 위한 시간을 지키세요. 병원 사회사업팀과 환우·보호자 모임은 보호자도 이용할 수 있습니다.

직장과 일상

- **언제·누구에게·얼마나** 말할지는 내가 정합니다. 직속 상사와 인사 담당자에게 "치료 일정 때문에 근무 조정이 필요하다" 정도만 알려도 충분한 경우가 많습니다.
- 치료 일정이 나오면 **근무 조정안**(단축근무, 재택, 연차·병가 조합)을 내가 먼저 제안하면 협의가 쉬워집니다.
- 피로는 치료 중 가장 흔한 증상입니다. 치료 직후 며칠은 일을 줄이는 계획을 미리 세웁니다.
- 자영업자라면 매출보다 **현금 흐름 3개월**을 먼저 계산하고, 사회사업팀에 지원제도를 문의합니다.
- 복귀는 한 번에 100%가 아니라 단계적으로. 복귀 시점은 담당 의사와 상의합니다.
- 암생존자통합지지센터(☎ 1577-9740)에는 직장·학교 복귀를 돕는 프로그램이 있습니다(지역별 운영 확인).

먹는 것과 움직이는 것

식사 원칙

- 치료 중 목표는 "특별한 음식"이 아니라 **체중과 근육 유지**입니다. 고른 식사와 충분한 단백질(생선·달걀·두부·살코기·유제품)을 챙깁니다.
- 암 치료에 특별히 좋은 음식이나 꼭 피해야 할 "나쁜 음식"이 따로 정해져 있지는 않습니다. "좋은 음식"만 먹거나 여러 음식을 가리면 오히려 영양이 치우치고 체력이 떨어져 치료를 버티기 어려워집니다.
- 입안이 험했을 때는 잡곡밥보다 부드러운 흰쌀밥이 나올 수 있고, 체중이 줄고 있다면 기름을 지나치게 제한할 필요도 없습니다. 유기농 식품이 치료에 특별히 도움이 된다는 근거는 뚜렷하지 않습니다.

- 체중이 한 달에 5% 이상 줄거나 먹는 양이 평소의 절반 이하로 1주 이상 이어지면 영양 상담을 요청합니다.
- 항암치료 중 면역이 떨어질 때는 날음식·덜 익힌 고기·살균 안 된 유제품을 피하라는 안내를 받을 수 있습니다. 병원 안내를 따르세요.
- **건강기능식품·한약·즙·고용량 비타민**은 항암제나 수술·방사선과 상호작용하거나 간·신장에 부담을 줄 수 있습니다. 시작 전에 꼭 의료진과 약사에게 보여 주세요.

움직이기

- 걷기처럼 가벼운 활동은 피로와 기분을 개선하는 근거가 있습니다. 컨디션에 맞춰 하루 10분부터 시작합니다.
 - 일반적인 건강 목표는 주 150분 중간 강도 활동이지만, 치료 중에는 **할 수 있는 만큼**이 기준입니다.
 - 발열, 심한 빈혈·어지럼, 뼈 전이 통증, 수술 직후에는 운동 강도를 의료진과 상의합니다.
 - 담배는 상처 회복과 치료 효과, 다른 암 위험에 모두 영향을 줍니다. 금연 클리닉(보건소)과 금연상담전화 ☎ **1544-9030**을 이용하세요.
-

PART 5. 돈 · 서류 · 제도

한국에서 꼭 챙길 제도와 서류

30초 요약

- 1. **산정특례 등록**: 암 확진 후 **30일 이내**에 신청하면 확진일부터 건강보험 본인부담이 크게 줄어듭니다(급여 항목 기준 5%). 진단받은 병원 원무과에 "산정특례 신청"을 오늘 물어보세요.
- 2. **서류는 처음부터 두 부씩**: 병리보고서, 영상 판독지, 진단서는 보험·회사·2차 소견에 반복해서 쓰입니다.
- 3. **제도는 바뀔니다**: 금액·기준은 2026년 10월 기준이며, 공단(1577-1000)·원무과에서 다시 확인합니다.

1. 산정특례(중증질환 본인부담 경감)

항목	내용(2026.10 기준, 확인 필요)
대상	암으로 확진된 환자(갑상선암 포함). 상피내암(0기)·경계성 종양 등은 대상·비율이 다를 수 있어 원무과 확인
혜택	건강보험 급여 진료비의 본인부담 약 5%(입원·외래). 비급여·선별급여는 해당하지 않거나 비율이 다름
기간	적용 시작일(확진일 또는 신청일)부터 5년. 5년 뒤 남아 있는 암·재발·전이가 있으면 재등록 심사
신청 시한	확진일로부터 30일 이내 신청하면 확진일부터 적용. 그 뒤에 신청하면 신청일부터 적용
방법	진단한 의사가 산정특례 등록 신청서를 작성 → 대부분 병원 원무과가 공단에 전송. 직접 제출도 가능

확인할 것

- ☐ 병원이 대신 접수했는지, 등록 결과(문자·공단 앱)를 받았는지
- ☐ 다른 병원으로 옮겨도 산정특례는 유지됩니다. 새 병원 원무과에 등록 사실만 알리면 됩니다.
- ☐ 확진 전 검사비는 적용 시점에 따라 경감되지 않을 수 있습니다.

2. 의료비 부담을 덜어주는 제도

제도	핵심	문의
본인부담상한제	1년간 낸 건강보험 본인부담금이 소득 구간별 상한을 넘으면 남은 금액을 돌려받음(비급여 제외)	국민건강보험공단 1577-1000
재난적 의료비 지원	소득·재산 기준을 충족하고 의료비 부담이 큰 경우 일부 지원(비급여 일부 포함)	공단 지사·병원 사회사업팀
국가 암환자 의료비 지원	의료급여 수급자·차상위 등 해당자 대상 지원	주소지 보건소
병원 사회사업팀 (의료사회복지사)	후원 연계, 간병·교통·숙소 정보, 제도 신청 도움	진료 병원 사회사업팀

대상 기준과 금액은 해마다 바뀝니다. "내가 해당되는지"는 병원 사회사업팀에 한 번에 물어보는 것이 가장 빠릅니다.

3. 보험 청구 서류 체크리스트

민간 암보험(진단비)

- ☐ 진단서(질병분류코드 포함) — 보험사 양식이 있는지 먼저 확인
- ☐ 조직병리검사 결과지(병리보고서) — 대부분의 약관이 병리 확정을 요구합니다

- □ 약관에서 "**유사암·소액암**"(갑상선암, 제자리암/상피내암, 경계성 종양, 기타 피부암 등) 분류를 확인 — 진단비가 다를 수 있습니다
- □ 청구 기한(보험금 청구권 소멸시효는 3년)

실손의료보험

- □ 진료비 영수증 + 진료비 세부산정내역서(비급여 항목 확인용)
- □ 일정 금액 이상은 진단서·입퇴원확인서 추가
- □ 가입 시기에 따라 보장 범위(비급여 주사·도수 등)가 다릅니다

보험 상담에서 "진단서는 몇 통이 필요한가요?"를 먼저 물어보고, 병원에서는 한 번에 필요한 부수만큼 발급받으면 비용과 시간을 아낄 수 있습니다.

4. 회사·학교에 낼 서류

- □ 진단서 또는 소견서(치료 예정 기간 포함 여부 확인)
- □ 회사 취업규칙의 **병가·질병휴직** 조항 확인 — 법정 의무 병가는 없고 회사 규정에 따름(공무원·교원은 별도 규정)
- □ 상병수당: 일부 지역 시범사업 중 — 거주 지역·자격을 공단에 확인
- □ 개인 의료정보는 **필요한 만큼만** 알립니다. 병명 공개 범위는 내가 정합니다 (PART 4 「직장과 일상」 참고).

5. 진료 서류 모아두기(2차 소견·전원 대비)

서류	어디서	메모
병리보고서(조직검사 결과지)	진단 병원 의무기록팀	바이오마커 결과 포함 여부
병리 슬라이드·파라핀 블록 대여	진단 병원 병리과	다른 병원 재판독·추가검사에 필요. 반납 기한 확인

서류	어디서	메모
영상 CD + 판독지	진단 병원 영상의학과· 의무기록팀	CT·MRI·PET 모두
혈액검사 결과	의무기록팀	최근 것
진료의뢰서(소견서)	담당 의사	상급종합병원 외래는 의뢰서가 있어야 건강보험 적용

갑상선암 참고: 질병코드는 C73입니다. 민간 암보험 상당수가 갑상선암을 **유사암·소액암**으로 분류해 진단비가 일반암보다 적습니다. 가입 시기·약관에 따라 다르므로 보험사에 확인하세요. 산정특례는 갑상선암도 대상이지만, 적극적 관찰 등 상황별 등록 시점은 원무과에 확인하세요.

PART 6. 진료실 도구

진료실 질문 모음 — 한 번에 3개씩

진단 직후에는 1~3번, 치료를 정할 때는 4~7번, 치료 시작 전후에는 8~10번 중 **3개만** 골라 가세요. 보호자가 답을 적으면 충분합니다. 1. 조직형과 Bethesda 단계는요? 2. 크기·위치·림프절·갑상선 밖 침범은요? 3. 제 재발 위험도는 어디에 해당하나요? 4. 적극적 관찰이 가능한가요? 5. 엽절제와 전절제 중 무엇을 권하시나요? 6. 수술 방법별 장단점은요? 7. 방사성요오드가 필요한가요? 8. 호르몬제와 TSH 목표는 어떻게 되나요? 9. 임신·수유 계획은 어떻게 맞추나요? 10. 바로 연락해야 할 수술 후 증상은요?

내 갑상선암 한 장 요약

항목	내 기록
조직형	유두 / 여포 / 호산성 / 저분화 / 수질 / 역형성
크기·위치	_ cm , _
Bethesda / K-TIRADS	_ / _
림프절	_____
재발 위험도	저 / 중간 / 고
첫 치료	관찰 / 엽절제 / 전절제
방사성요오드	해당 없음 / 예정 / 완료
TSH 목표	_____
산정특례·보험	☐ 확인

오늘 꼭 물을 3가지: ① 관찰이 가능한가요? ② 수술 범위는? ③ 방사성요오드가 필요한가요?

같은 진단, 다른 30일 (가상 사례)

감수단 환자 페르소나를 바탕으로 재구성한 가상의 이야기입니다.

34세 수진 씨 — 미세유두암, 임신 계획 관찰과 엽절제 사이에서 고민했다. 임신 계획을 먼저 말하자, 담당의는 두 경우 모두의 타임라인을 그려 주었다. "선택지가 둘 다 '맞는 길'이라는 걸 알고 나니, 제 삶에 맞춰 고를 수 있었어요."

52세 지영 씨 — 전절제 후 방사성요오드 저요오드 식단이 가장 막막했다. 병원 식단표와 장보기 목록으로 2주를 버텼고, 퇴원 후 며칠은 손주와 거리를 뒀다. "무엇을 왜 하는지 알면, 불편해도 견딜 만해요."

71세 석진 씨 — 저분화암 "착한 암이라는데 왜 나는 다르냐"고 물었다. 담당의는 조직형의 차이를 설명하고 다학제 진료와 분자검사를 연결했다. "제 병을 정확히 부르는 이름을 알게 된 게 시작이었습니다."

용어사전

용어	쉬운 뜻
분화암	유두암·여포암 등 정상 갑상선 세포와 비슷한 암
Bethesda 분류	세포검사 결과 6단계
K-TIRADS	한국 갑상선 초음파 위험 등급
NIFTP	암에서 저위험 종양으로 재분류된 병변
적극적 관찰	정기 초음파로 지켜보는 치료 전략
엽절제 / 전절제	한쪽 / 양쪽 갑상선 제거

용어	쉬운 뜻
완결 갑상선절제술	엽절제 후 남은 쪽 추가 제거
방사성요오드(RAI)	남은 갑상선 조직·전이를 없애는 먹는 방사선
저요오드 식사	RAI 효과를 높이기 위한 식이
재조합 TSH	호르몬제를 끊지 않고 TSH를 올리는 주사
티로글로불린	갑상선 조직이 만드는 단백질, 추적 표지자
부갑상선	칼슘을 조절하는 작은 샘

자주 묻는 질문 12

Q1. 갑상선암은 정말 수술하지 않아도 되나요? 1cm 이하 저위험 유두암 일부는 적극적 관찰이 선택지입니다. 위치·세포 소견·나이·선호를 함께 보고 정합니다.

Q2. 수술을 미루면 퍼지지 않나요? 분화암은 대부분 천천히 자라 몇 주~몇 달의 계획 기간이 결과에 큰 영향을 주지 않는 경우가 많습니다. 다만 저분화·역형성·수질암은 다릅니다.

Q3. 엽절제 후 호르몬제를 먹어야 하나요? 남은 갑상선이 충분히 호르몬을 만들면 먹지 않아도 됩니다. 수술 후 혈액검사로 결정합니다.

Q4. 호르몬제는 언제 먹어야 하나요? 아침 공복에 물과 함께, 식사 30~60분 전. 철분·칼슘제·일부 위장약과는 4시간 간격을 둡니다.

Q5. 목소리가 바뀌었어요. 수술 후 일시적인 쉼 목소리는 흔하며 대부분 좋아집니다. 몇 달 이상 지속되면 이비인후과 평가를 받습니다.

Q6. 방사성요오드 치료 후 아이를 안아도 되나요? 투여량별 병원 지침에 따라 며칠간 거리를 두도록 안내받습니다. 기간은 병원에서 정해 줍니다.

Q7. 저요오드 식사 중 김치는 먹을 수 있나요? 시판 김치·젓갈은 요오드가 많을 수 있어 대개 피합니다. 정제염으로 직접 담근 김치는 병원 식단표 기준을 따르세요.

Q8. 임신은 언제 할 수 있나요? 방사성요오드 치료 후에는 일정 기간 임신을 미룹니다(담당 핵의학과 확인). 수술만 한 경우나 관찰 중이라면 계획을 미리 알려주세요.

Q9. 티로글로불린 수치가 올랐어요. 여러 원인이 있을 수 있어 추세와 영상으로 판단합니다. 한 번의 수치로 재발을 단정하지 않습니다.

Q10. 운동은 언제부터 괜찮나요? 수술 후 상처가 아물면 대부분 가능합니다. 목을 심하게 젖히는 동작은 초기에 피하세요.

Q11. 가족도 검사를 받아야 하나요? 대부분 유전과 무관하지만, **수질암**은 RET 유전검사와 가족 검사가 권장됩니다.

Q12. "착한 암"이라는 말이 서운합니다. 그 마음은 정당합니다. 예후가 좋은 편이라도 진단·수술·회복은 큰 일입니다. 주변에 "그냥 고생했다고 말해 줘"라고 요청해도 됩니다.

진료실 대화법: 15분 진료를 30분처럼

30초 요약: 질문은 3개로 줄여 가져가고, 보호자가 적고, 마지막에 "제가 이해한 것이 맞는지 말해 볼게요"로 확인합니다.

진료 전날

- 질문 3개를 우선순위로 적기(워크북 W2)
- 지난 진료 이후 바뀐 증상·약을 한 줄씩
- 검사 결과지·영상 CD·복용 약 목록 챙기기

진료실에서

1. **첫 문장으로 가장 중요한 것부터:** "오늘 가장 궁금한 건 첫 치료가 무엇이고 언제 시작하는지예요."

2. 어려운 말이 나오면: "그 말을 쉽게 다시 설명해 주시겠어요?" "종이에 적어 주실 수 있나요?"
3. 선택지가 나오면: "선택지마다 장점과 단점, 그리고 선생님이라면 무엇을 고르실지 여쭙봐도 될까요?"
4. 끝나기 전: "제가 이해한 대로 말해 볼게요. ○○하고, 다음은 ○월 ○일 ○○ 검사죠?"
5. 연락처: "집에서 문제가 생기면 누구에게 연락하나요?"

녹음하고 싶다면

진료 내용을 기억하기 위해 녹음하고 싶을 때는 **먼저 의료진에게 양해를 구하세요.** 허락이 어려우면 보호자 기록으로 대신합니다.

다학제 진료

여러 과(수술·종양내과·방사선종양학과·영상의학과·병리과 등)가 한자리에서 치료를 상의하는 진료입니다. 치료 선택지가 여럿이거나 순서가 중요한 경우 "다학제 진료를 받을 수 있나요?"라고 물어보세요.

검사 준비 카드

검사	준비	알려야 할 것	소요(대략)
CT(조영)	몇 시간 금식(병원 지시), 물 충분히(제한 없을 때)	조영제 알레르기, 신장 기능 저하, 당뇨약 (메트포르민), 임신 가능성	촬영은 10~20분
MRI	금속 제거, 일부는 금식	심박동기·인공와우·몸속 금속, 폐소공포증(진정 상담), 신장 기능	30~60분

검사	준비	알려야 할 것	소요(대략)
PET/CT	(FDG PET) 4~6시간 금식, 전날 격한 운동 피하기 · 다른 종류의 PET은 병원 안내	당뇨(혈당 조절법 미리 확인), 임신·수유	주사 후 대기 포함 2~3시간
조직검사 (바늘)	금식 여부 확인	혈액을 묽게 하는 약(중단 여부는 의료진 지시), 알레르기	시술 후 관찰 수시간
내시경	금식, 대장은 장 정결제	혈액을 묽게 하는 약, 당뇨약	진정 시 보호자 동행·당일 운전 금지
빠스캔	주사 후 물 많이 마시기	임신·수유	주사 후 2~4시간 대기

검사 결과는 "검사를 한 날"이 아니라 **"결과 설명을 듣는 날"**을 미리 예약해 두면 기다리는 불안이 줄어듭니다.

워크북

이 장은 오려 쓰거나 복사해 쓰도록 만들었습니다. 진료실에는 이 페이지만 들고 가도 됩니다.

W1. 비상 연락처 카드 (휴대폰 사진으로도 저장)

항목	기록
담당 교수 / 진료과	
평일 진료실·외래 간호사실 ☎	

항목	기록
야간·휴일 연락처 ☎	
가까운 응급실(치료 병원 우선)	
항암·방사선 치료실 ☎	
보호자 1 / 보호자 2 ☎	
국가암지식정보센터 암정보 상담(평일 9~18시)	☎ 1577-8899
암생존자통합지지센터(지역암센터)	☎ 1577-9740
응급 119 · 정신건강 위기 109	

W2. 진료 기록지 (진료마다 1장)

항목	기록
날짜 / 진료과 / 의사	
오늘 들은 진단·병기	✓ / ⏳ / ?
오늘 결정된 것	
다음 검사·날짜	
다음 진료 날짜	
새로 받은 약	
꼭 지켜야 할 주의사항	
다음에 물어볼 것	

W3. 7일 증상 일지

날 짜	체온 (최고)	통증 0~10	식사(평소의 %)	배변· 배뇨	잠	기분 0~10	메모·연락 여부

W4. 복용 약·보충제 목록 (모든 진료에 지참)

이름	용량·횟수	왜 먹나	처방한 곳	의료진에 알림
				☐
				☐
				☐
				☐

혈액을 묽게 하는 약(항응고제·항혈소판제), 당뇨약, 한약·건강기능식품은
수술·시술·항암 전에 특히 중요합니다.

W5. 30일 체크 달력

주	날짜	한 일(✅) / 남은 일(⌚)
1주	Day 0-7	
2주	Day 8-14	
3주	Day 15-21	
4주	Day 22-30	

근거와 한계

- **참고 지침:** NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) — Thyroid Carcinoma, Version 2.2026. NCCN의 표·알고리즘·문장을 옮기지 않고, 환자 언어로 새로 썼습니다.
- **국내 자료:** 국가암지식정보센터(www.cancer.go.kr) 갑상선암 정보, 대한갑상선학회·대한내분비외과학회 자료, 국민건강보험공단 산정특례 안내
- **국가암지식정보센터 자료의 이용 방식:** 이 책은 국가암지식정보센터(구 국가암정보센터)의 글·표·그림을 옮기거나 고쳐 실지 않았습니다. 같은 사실을 대조·확인하는 데 참고했고, 문장은 ApuDa가 새로 썼습니다(센터 저작권 안내의 이용조건: 비영리·저작권 표시·내용 변경 금지·영리 이용 시 사전 협의를 따릅니다).
- **참고문헌:** 보건복지부·국립암센터 국가암지식정보센터, 갑상선암 정보(확인일 2026.10.04). 사실 확인용 참고문헌이며, 국가암지식정보센터의 저작물을 수록하지 않았습니다. 독자 안내: 공식 암 정보와 무료 상담은 www.cancer.go.kr, ☎ 1577-8899.
- **의학정보 확인일:** 2026.10.04. 약의 국내 허가·급여, 면역치료·표적치료 적용 기준, 제도 금액은 바뀔 수 있습니다.
- **감수:** ApuDa 「첫 30일」 감수단(전문의 30인·환자 36인·편집자문 3인 역할 기반 **AI 사전 검토단**)의 1·2차 검토를 반영했습니다. 이 검토는 실제 면허 의료진의 최종 감수를 대신하지 않습니다. 출판본에는 실제 감수자 명단이 별도 표기됩니다.
- 이 책은 NCCN이 검토·승인한 자료가 아니며, NCCN과 무관한 ApuDa의 독자적 환자교육 저작물입니다.
- 이 자료는 일반적인 환자교육용이며 개인의 진단·처방·치료 결정을 대신하지 않습니다.